



Psychologie de la prescription

Dr Bououden Naila

Université 3 de Constantine



Plan du cours:

- I-Introduction
- II- Prescription et subjectivité du médecin
- III-Déroulement de la prescription
- IV. Observance et alliance thérapeutique
- V. Statut du médicament
- VI. La prescription comme un élément de langage dans la relation médecin-malade



I-Introduction

*Dans l'exercice de la médecine, la prescription est :

- L'acte par lequel un professionnel de la santé habilité ordonne des recommandations thérapeutiques (médicamenteuses ou non), des actes de soins et protocoles de soins auprès d'un patient , ou à un groupe de personnes.
- L'application du plan thérapeutique proposé par un médecin , élaboré selon son diagnostic et les pratiques contemporaines de la médecine moderne .



I-Introduction



- Le temps de la prescription est **un moment clé** de **la relation médecin-malade** ; le médicament est **un support, un médiateur, une concrétisation** de cette relation thérapeutique.
- **L'observance du traitement** prescrit varie selon de nombreux facteurs, conscients et inconscients, dont la diversité rend ce concept difficile à modéliser et étudier.

II. Prescription et subjectivité du médecin

- Prescription: Le médecin **fait le lien** entre **un diagnostic** et **un moyen** (substance, acte chirurgical, thérapie) pour le traiter.
- Rédiger une ordonnance, la signer est un acte **qui confirme** le **caractère morbide** de l'état du patient et valide la nécessité de recourir à un soin.
- **Identification** du patient à la maladie
- Il est question à l'heure actuelle **de consultations hyperspécialisées**, d'une sophistication telle que le sujet disparaît derrière un arsenal diagnostique et thérapeutique
- Le patient n'est plus considéré comme un sujet à part entière mais comme **une maladie, un organe atteint**.
- Le médecin **n'a plus l'image de tout savoir** (il ne s'occupe plus de tous les organes, et doit faire appel à d'autres collègues...
- Médecins moins impliqués : **Patients clivés** ...L'importance du médecin généraliste coordinateur



III-Déroulement de la prescription

- Une approche systémique préconisée par l'OMS peut minimiser les prescriptions erronées et de mauvaises qualité.
- Cette approche en six étapes suggère que le médecin doit :
- 1. Evaluer et définir le problème du patient :
 - * Il s'agit initialement de clarifier si le patient présente une maladie nécessitant un traitement ou s'il vient chercher une prescription,
 - * S'il y a une anxiété ou un problème social sous-jacent,
 - * S'il s'agit d'un effet secondaire d'un médicament,
 - * S'il s'agit d'une non-adhésion au traitement,
 - * Ou d'une demande d'un traitement préventif.



III-Déroulement de la prescription

- 2. Spécifier l'objectif thérapeutique :
- Il s'agit de clarifier le but d'un traitement avec le patient avant de prescrire un médicament. Ce que le patient attend d'une prescription peut être différent des objectifs thérapeutiques du médecin.

III-Déroulement de la prescription

- 3. Choisir le traitement approprié
- Ce dernier doit être efficace, adéquat et économique.
- L'OMS recommande au médecin de définir sa propre liste personnelle de médicaments (P(ersonnal)-drugs). Les P-drugs devraient être des médicaments efficaces, avantageux, bien tolérés, que le médecin a l'habitude de prescrire et dont il connaît aussi bien les effets bénéfiques, les effets secondaires que les interactions.
- Prendre en compte les propriétés pharmacodynamiques et pharmacocinétiques des médicaments prescrits vérifier les interactions médicamenteuses.
- Prendre en compte les croyances et représentations du patient (les préjugés, attentes, craintes), afin d'assurer une adhésion thérapeutique au médicament envisagé.



III-Déroulement de la prescription

- 4. Ecrire l'ordonnance:
- De façon **lisible** et **précise**, comportant **toutes les informations utiles**. Les ordonnances présentent un grand nombre d'imprécisions, peuvent conduire à **des problèmes médicaux** comme l'absence d'indication quant à la quantité et la durée prévue de la prescription.



III-Déroulement de la prescription

- 5. Donner les informations, explications et avertissements nécessaires :
- Il s'agit des **instructions** et **informations** afin de lui en faciliter l'usage et concernant :
 - ☐ Raison du traitement
 - ☐ Effets secondaires
 - ☐ Instructions de prise
 - ☐ Avertissements : quand ne pas prendre le médicament, quelle est la dose maximale
 - ☐ Suivi : quand reconsulter .
 - ☐ Vérifier la compréhension du patient

III-Déroulement de la prescription

- 6. Evaluer le traitement régulièrement:
- En moyenne, un patient sur deux a des difficultés à suivre son traitement, il faut, dans ce cas, un apprentissage des outils de communication comme la reformulation et l'analyse de la situation.
- Les auteurs ajoutent deux étapes supplémentaires :
- 7.tenir compte du coût du médicament lors de la prescription ;
- et 8. utiliser des ordinateurs et d'autres outils pour réduire les erreurs de prescription.
- Ces huit étapes, combinées à un apprentissage autonome continu, constituent une approche systématique de la prescription efficace et pratique pour le médecin de famille.

IV. Observance et alliance thérapeutique

- 1. Observance :
- L'observance ou « **compliance** » désigne, en médecine, « **l'obéissance** liée à la **confiance**, la rigueur plus ou moins grande avec laquelle le patient se plie à la prescription du médecin » (Burner, 1990) .
- Corollaire de **l'implication** du médecin .
- Le médicament **n'est jamais accepté de façon durable** ; il soulage un temps, à l'image d'une béquille .



IV. Observance et alliance thérapeutique

- ☐ L'observance est une problématique aussi ancienne que la médecine elle-même. Déjà, Hippocrate remarquait que « le médecin doit savoir que les patients mentent souvent lorsqu'ils disent suivre leurs traitements » (Alvin, 1997).
- ☐ L'observance est complexe et se décline de multiples façons, depuis la fidélité exemplaire jusqu'au refus complet.
- ☐ Mauvaise observance = mauvais malade
- ☐ L'observance phénomène transnosographique, multi varié et poly factoriel:
- ☐ Tabou - Echec
- ☐ Dénier - **danger**
- ☐ Incompréhension mutuelle



IV. Observance et alliance thérapeutique

- • Chez l'enfant , l'adolescent, ou la personne dépendante : L'analyse de l'observance prise en compte de la place des parents.
- • Conduites de rupture de traitement dans un contexte familial non contenant.
- • Il s'agit là d'une autre alliance thérapeutique, celle des parents, que le médecin devra prendre en compte.



IV. Observance et alliance thérapeutique

- 2. Alliance thérapeutique :
- ☐ C'est la complaisance avec le médecin c-à-d **avoir une bonne relation médecin-malade**, avec toute la dimension affective que cela comporte. Désir de plaire et soumission ne sont pas loin...
- L'alliance thérapeutique inclue une responsabilité partagée et une collaboration efficace (Valente, 2009)
- ☐ L'alliance thérapeutique $\neq$ l'observance
- ☐ La non observance »ordinaire « $\neq$ des comportements auto destructeurs



IV. Observance et alliance thérapeutique

➤ 3.Valeurs psychopathologiques de la non observance:

➤ ☐ Les réticences initiales à une bonne observance sont normales

➤ ☐ La non- observance peut avoir plusieurs fonctions:

* Une tentative, certes maladroite, de prise de distance par rapport aux parents, au médecin, au corps malade.

* L'essai de réappropriation du corps.

* La recherche d'un espace de liberté.

* La réponse à une pulsion (irréfléchi).



V. Statut du médicament

- Dans la prescription, le médicament peut revêtir plusieurs statuts :
- ☐ **Celui d'objet transitionnel** : c.à.d qu'il rend le trouble concret alors qu'il était imprécis et dissimulé. Il témoigne de la maladie.
- ☐ **Celui d'objet de projection** : c.à.d sur lequel vont se focaliser et se projeter les affects et les conflits du patient.
- ☐ **Celui d'un représentant symbolique du thérapeute** et des relations entretenues avec lui.
- ☐ **Celui d'un objet contra phobique** : tant pour le médecin que pour le patient et sa famille.
- ☐ **Celui d'un objet symbolique** : beaucoup de médicaments sont investis de fonctions thérapeutiques qui s'attachent plus à des croyances qu'à des réalités.